

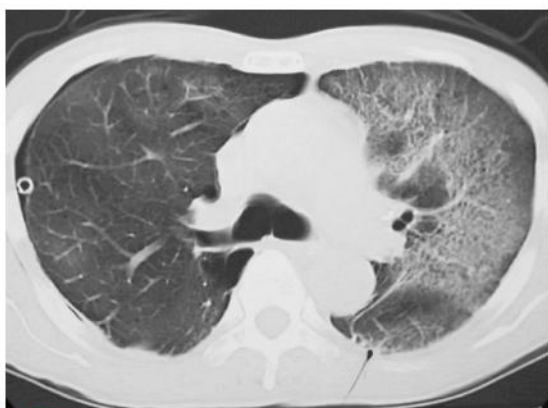


図2 再拡張性肺水腫のCT像
右気胸ドレナージ後、左の対側肺に著明な肺水腫、右の患側肺に軽度の肺水腫が認められる。

気胸で重篤化する病態

気胸に際して重症化する5つの病態を次に示す。

a 両側同時気胸

窒息状態と同じになるので積極的なドレナージ治療が必要である。

b 血気胸

気胸時に血管の含まれた索状癒着が剥離して胸腔内出血が続く。緊急の手術が必要になる。

c 緊張性気胸

肺から空気が漏れ続け胸腔内に空気が緊満状態になり、心臓や対側肺を圧迫してショック状態となる。積極的な胸腔ドレナージが必要である。

d 再拡張性肺水腫

長期間の肺虚脱や完全虚脱に胸腔ドレナージを行った場合、肺水腫がしばしば認められる。患側肺にも対側肺にも起こりうる(図2)。ドレナージ後は持続吸引を行わずに水封状態にするか、断続的に吸引をするなど急速な肺膨張を防ぐ必要がある。発症した場合には酸素投与・ステロイド投与などが行われる。

Advanced

■気胸治療の難しさ

呼吸器内科医は治療手段として胸腔ドレナージと胸膜癒着療法およびEBOがある。しかしながら、続発性気胸では、肺の側副換気が発達しているため、中枢気管支側で止めるEBOでは空気漏れを止めることがほとんどできない。他方そうした例には胸膜癒着療法を行うことが多いが、胸膜癒着療法は不確実な治療法であり、安易な癒着療法は手術が必要となるとき大きな弊害となるため適応には十分注意が必要となる。初期から呼吸器外科医と綿密な協議をしながら治療にあたることが望ましい。

気胸治療のガイドラインはACCP^{A)}またはBTS^{B)}や日本気胸・肺性肺疾患学会などが存在するが、医療制度や気胸治療の考え方の違いから内容が大きく異なる。また、気胸肺囊胞疾患は治療後に十分な予後調査ができていない。気胸は病態でありさまざまな基礎疾患で発症するため、肺癌のような単一病名に基づいたガイドラインが作成できない。ここに気胸治療の標準化やガイドライン化の難しさがある。

A) Baumann BH, et al: ACCP 119: 590, 2001

B) MacDuff A, et al: Thorax 65: 18, 2010

e 進行性皮下気腫

COPDの高齢者に認められることが多い。胸腔ドレナージを行った際、空気の吸引量より排出量が多い場合に、チューブ挿入部周囲から空気が皮下の脂肪組織に漏れ出て、皮下気腫が進行性に拡大する。2本目のチューブを追加する、またはチューブ周辺に皮膚切開を行う。最終的には緊急手術も考慮する。

文 献

- 1) 大須賀穰ほか：稀少部位子宮内膜症診療ガイドライン、診断と治療社、2018
- 2) Kurihara M, et al: Gen Thorac Cardiovasc Surg 58: 113, 2010
- 3) Kurihara M, et al: Pros ONE <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0163637> 2016